EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS
N° EGRESO : 81416
SERVICIO : CIRUGIA HSC
FECHA : 27-03-2024

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: NICOLAS ALEXIS BAHAMONDEZ POBLETE			RUN	: 22.334.444-5
F.Nac	: 20-02-2007	Edad	: 17 AÑOS, 1 MES	Género	: Masculino
Dirección	: ENRIQUE DONOSO 311			Comuna	: RECOLETA
Previsión	: FONASA D	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-03-18	Fecha Egreso	: 27-03-2024	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. V23.5-MOTOCICLISTA LES. POR COLIS.C/AUT.PASAJ.LES.AN ACC.TRANSITO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1- TEC COMPLICADO MODERADO
2- HEMATOMA EXTRADURAL FRONTAL DERECHO
3- FX FRONTAL DERECHA
4- HSA TEMPORAL/LAD I.
-18/03/2024: VACIAMIENTO DE HEMATOMA EXTRADURAL FRONTAL DERECHO.

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. V23.5-MOTOCICLISTA LES. POR COLIS.C/AUT.PASAJ.LES.AN ACC.TRANSITO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. T06.0-TRAUMATISMOS DEL ENCEFALO Y DE NERVIOS CRANEALES CON TRAUMA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. S06.4-HEMORRAGIA EPIDURAL (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
4. S02.3-FRACTURA DEL SUELO DE LA ORBITA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
5. S02-FRACTURA DE LOS HUESOS DEL CRANEO Y DE LA CARA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

PACIENTE CON ANTECEDENTE DE CAIDA EN MOTOCICLETA. DERIVADO DESDE HSC A HCHM CON TAC CEREBRO QUE EVIDENCIA HSD FRONTAL D°. A SU LLEGADA A HCHM, GCS 12 EN TABLA ESPINAL Y CON COLLAR CERVICAL. EVALUADO POR NEUROCIRUGIA, SIN INDICACION QUIRURGICA DE MOMENTO. INGRESA A UPC PARA MONITOREO Y CONTROL TAC CEREBRO. INGRESA GCS 12, PUPILAS ISOCORICAS SIN FOCALIDAD. SE SOLICITA TAC CEREBRO CONTROL QUE INFORMA HEMATOMA EXTRADURAL FRONTAL DERECHO DE 43 MM DE ESPESOR MAXIMO QUE EJERCE EFECTO DE MASA QUE DEFORMA SISTEMA VENTRICULAR SUPRATENTORIAL DESVIANDO LÍNEA MEDIA 13 MM A IZQ. EVOLUCIONA CON DETERIORO DE GCS (GCS 7) Y ALTERACION PUPILAR POR LO QUE SE REALIZA DRENAJE QX DE URGENCIA 18/03/2024. REINGRESA A UNIDAD POSTOPERADO EN INTUBACIÓN OROTRAQUEAL, BAJO VENTILACIÓN MECANICA Y SEDACIÓN. SE RALIZA TAC CONTROL QUE EVIDENCIA HSD DE MENOR

REPRESENTACIÓN CON CAMBIOS POSTQUIRURGICOS, SIN OTRAS ALTERACIONES. SE MANTIENE CON DVA PARA META PAM. SE MANTIENE ANTIBIOTICO PROFILÁCTICO POR EXPOSICION ÓSEA CON CEFAZOLINA. EL 19/03/2024 SE SUSPENDE SEDACION POR TAC CONTROL 19/03/2024 SIN CAMBIOS. MEJORA GCS Y SE PLANEA EXTUBACIÓN, QUE SE REALIZA 20/03/2024, SIN INCIDENTES. SE SUSPENDEN DVA. SE EVIDENCIA AUMENTO PARÁMETROS INFLAMATORIOS POR LO QUE POR OBS DE NEUMONÍA ASPIRATIVA SE INICIA CEFTRIAXONA + CLINDAMICINA PARA COMPLETAR 7 DÍAS. EVALUADO POR CIRUGIA MAXILOFACIAL POR FRACTURAS FACIALES, SIN EMBARGO NO SE PUEDE REALIZAR EXAMEN FÍSICO ADECUADO DE MOTILIDAD OCULAR Y VISIÓN POR FALTA DE COOPERACIÓN DE PACIENTE, EN TAC SE OBSERVA FRACTURA FRONTOMALAR DERECHA Y PISO DE ÓRBITA DERECHA NO DESPLAZADA POR LO QUE NO TIENE INDICACION QUIRURGICA DE MOMENTO. PENDIENTE REEVALUACIÓN. SE REALIZA TAC CONTROL 21/03/2024 SIN CAMBIOS AGUDOS, GCS 15, SIN FOCALIDAD NEUROLÓGICA, CON PARÁMETROS INFLAMATORIOS A LA BAJA. POR EVOLUCION CLÍNICA, SE DECIDE TRASLADO A SALA PARA CONTINUAR MANEJO. DURANTE ESTADIA EN SALA, PACIENTE EVOLUCIONA FAVORABLEMENTE, SIN COMPROMISO NEUROLÓGICO NI HEMODINAMICO. APETITO CONSERVADO, MARCHA CONSERVADA, CLOTE GLASGOW 15. EVALUADO POR NEUROCIRUGIA AYER QUIEN INDICA ALTA TRAS COMPLETAR 7 DIAS CEFTRIAXONA CLINDAMICINA. CURACIONES CADA 4 DIAS POR HODOM Y CONTROL EN 15 DIAS POLI NEUROCX.

INDICACIONES AL ALTA

1. ENVIO A HODOM PARA CURACIONES
2. REPOSO RELATIVO
3. REGIMEN LIVIANO A TOLERANCIA
4. PARACETAMOL 500 MG 2 COMP CADA 8 HRS X 10 DIAS VO (SOS)
5. METOCLOPRAMIDA 10 MG CADA 8 HRS X 10 DIAS VO (SI NAUSEAS)
6. LEVETIRACETAM 500 MG 1 COMP CADA 12 HRS VO
7. KNT MOTORA
8. CURACION DE HERIDA CADA 4 DIAS
9. RETIRO CORCHETES EN 8 DIAS
10. CONTROL POLI NEUROCX EN 15 DIAS
11. URGENCIAS SOS

Control en: 15 días en HOSPITAL DE SAN CARLOS

Felipe Rodolfo Escobar Kunz
MEDICO TRATANTE
19243461-0

JEFE SERVICIO